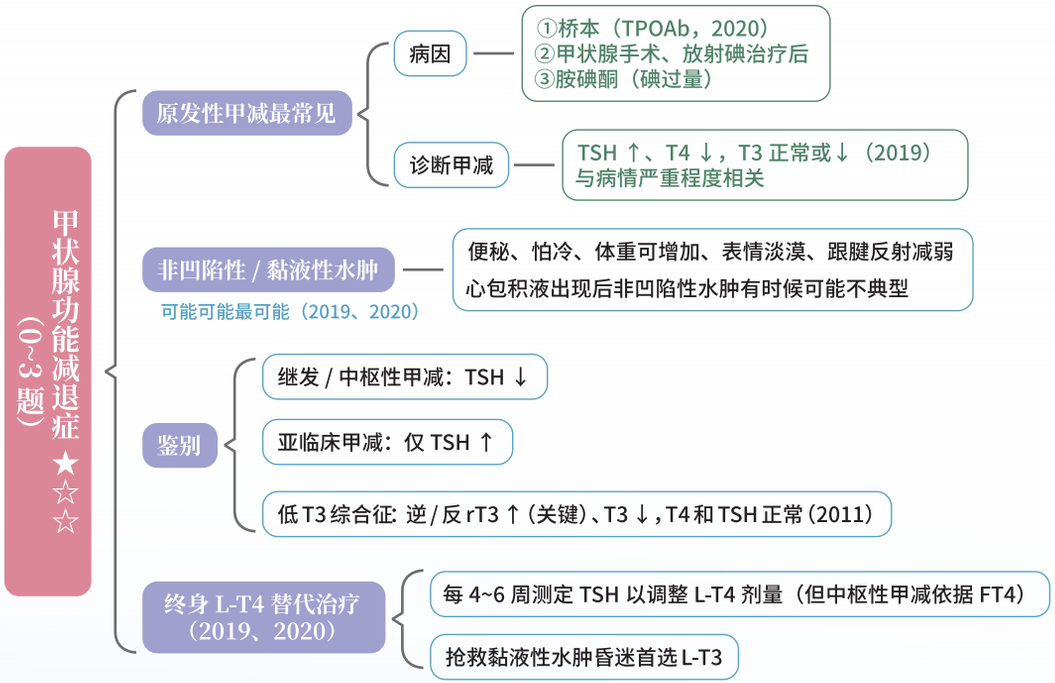

甲状腺功能减退症 ★☆☆
（0~3 题）
原发性甲减最常见
病因
①桥本（TPOAb，2020）
②甲状腺手术、放射碘治疗后
③胺碘酮（碘过量）
诊断甲减
TSH ↑、T4 ↓，T3 正常或↓（2019）
与病情严重程度相关
非凹陷性 / 黏液性水肿
可能可能最可能（2019、2020）
便秘、怕冷、体重可增加、表情淡漠、跟腱反射减弱
心包积液出现后非凹陷性水肿有时候可能不典型
鉴别
继发 / 中枢性甲减：TSH ↓
亚临床甲减：仅 TSH ↑
低 T3 综合征：逆 / 反 rT3 ↑（关键）、T3 ↓，T4 和 TSH 正常（2011）
终身 L-T4 替代治疗
（2019、2020）
每 4~6 周测定 TSH 以调整 L-T4 剂量（但中枢性甲减依据 FT4）
抢救黏液性水肿昏迷首选 L-T3